EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	71947
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-10-07 13:00:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN AGUSTIN MARQUEZ MARQUEZ			**RUN**	: 6.540.258-0
F.Nac	: 26-09-2023	**Edad**	: 0 AÑO	**Género**	: Masculino
Dirección	:			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 26-09-2023	**Fecha Egreso**	: 2023-10-07 13:00:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico multiples fronto-parietal izquierdo
-FA en DOAC
-Neumonía aspirativa en tto 3/7 (2° curso ATB)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Paciente previamente en su basal, presentó el 26/9, aprox a las 9.30 AM una malestar cefálico indefinido (aparentemente pudo haber despertado asintomático a las 09 AM, dato dudoso), posteriormente temblor de ESD y sensación de desmayo. Fue traslado por familiares hasta SU HSC, durante el trayecto presenta disminución progresiva de la fluencia del habla hasta llegar practicamente al mutismo, asociado a rigidez de hemicuerpo derecho al bajarlo del vehículo. Ingresó a SU HSC sin lateracion de signos vitales, se describe recuperación del lenguaje y fuerza M3 en hemicuerpo derecho.
AngioTC cerebro y cuello muestra suboclusión larga de M2 posterior izquierda y lesiones isquémicas secuelares cerebelosa hemisférica y parietal derechas, no observo lesiones agudas evidentes. Exs de lab sin hallazgos significativos.
Se hospitaliza para evaluación y manejo.

Evolución
Paciente BEG, HDN estable, FA s/RVR, afebril, eupneico, tolera bien alimentación VO de consistencia pudding (IDDSI 0-5) y marcha con andador, se observa tranquilo y cooperador, refiere tos muy ocasional, niega otras molestias, mantiene mejoría progresiva en lenguaje, fuerza en hemicuerpo derecho recuperada, sin recurrencias.
AngioTC cerebro de control muestra infarto frontal opercular izquierdo sin TH y recanalización casi completa de M1 distal y M2 proximal con escasos restos de trombos intraluminales.
TC cerebro s/c de control de ayer muestras multiples infartos frontales operculares- laterales y parietales altos izquierdos sin TH.
Se decide inicio de TACO con dabigatran 110 mg c/12h, y aumento dosis de bisoprolol a 2.5 mg/d para mejorar control de FC . Sin RAM por DOAC.
TC tórax describe imagenes sugerentes de neumonía aspirativa leve, se inició tto ATB VO con amoxicilina/ac clavulánico por presencia de tos productiva y esputo purulento, sin disnea ni CEG; PCR se elevó, se deicidió cambio a píperacilina tazobactam con descenso de PCR, CSB negativo.
Exs de lab con PCR estacionaria, sin leucocitosis y procalcitonina baja, decido completar 3 días de ATB EV y luego traslape a VO con levofloxacino por 4 días más.
Pendiente ETT.
Se decide alta a domicilio mañana sábado 7/10/23, IC a HODOM para continuar rehabilitación y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico de Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Atorvastatina 40 mg/n
2. -Ipratropio 2 puff c/6h por 5-7 días
3. -Bisoprolol (2.5 mg) 2.5 comp/día
4. -Dabigatran 110 mg c/12h
5. -Levofloxacino 500 mg/d por 4 días desde el 7/10/23
6. -Omeprazol 20 mg/d

7. -Reiniciar tto crónico por artritis reumatoide luego de completado tto antibiótico, excepto indometacina y cloruro de potasio (por riesgo de hemorragia gástrica). No reiniciar carvedilol ni enalapril. Usar meloxicam solo SOS en caso de dolor articular (evitar mas de 5 días de uso continuo)

EXÁMENES Y RESULTADOS

6/10/23
-Crea 0.9 MDRD 80.79 Uremia 54
-PCR 74.1
-Na 144 K 3.9 Cl 110
-Hb 15.1 Leu 9800 Plaq 213000 Seg 76
-Procal 0.06

5/10/23
-Crea 0.8 MDRD 92.55 Uremia 48
-PCR 74
-Na 141 K 3.9 Cl 106
-Hb 14.5 Leu 9700 Plaq 213000 Seg 75
-Procal 0.06

3/10/23
-Crea 0.6 MDRD 128.99 Uremia 54
-PCR 145.7
-Na 141 K 4.3 Cl 106
-Leu 10700 Hb 15.6 Plaq 202000 Seg 79
-Procal 0.08
2/10/23
-Crea 0.7 MDRD 107.97 Uremia 48
-PCR 88.1
-Na 141 K 4.2 Cl 101
-Leu 10000 Hb 15.7 Plaq 233000 Sef 72 VHS 68
-Procal 0.1

28/9/23
-Alb 3.4
-Crea 0.6 MDRD 128.99 Uremia 40
-AU 4.4
-Ca 8.2 Ca corr Na 136 K 3.7 Cl 102
-PCR 44
-Leu 8300 Hb 15 Plaq 185000 Seg 72 VHS 11
-TSH 1.553 T4L 1.39
-B12 433 Folato 23.7
-Procal 0.05
-Hb glic 5.9
-RPR N/R

26/9/23
-Glic 155
-Crea 0.6 MDRD 128.99 Uremia 48
-AU 4.5
-Ca 8.6
-FA 75 BI 0.4 BD 0.1 BT 0.5 GOT 40 GPT 49 GGT 90
-ColT 167 TG 111
-PCR 9
-Na 139 K 3.8 Cl 103
-Hb 14.3 Leu 8500 Plaq 176000 Seg 69
-INR 1.15 TTPA 25

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RII 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no plapo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, OTE, atingente, lenguaje más fluente, nomina 6/8 con leve dificultad, repite frases largas de hasta 5 palabras, comprende órdenes de 4 pasos, distingue derecha-izquierda cruzando la línea media (con dificultad)
-PC: CV N por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve a mínima, disartria(-), nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: M5 en las 4 EE, RCP extensor derecho y flexor izquierdo
-Sensitivo: algesia impresiona conservada

-Cerebelo: conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO